Épidémie d'IRA ou de GEA en ESMS

Cas groupés d'infections respiratoires aiguës ou de gastro-entérites : agir, signaler, clôturer.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME — médecins coordonnateurs, IDEC, médecins DOTR

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

SIGNALER

IRA : au moins 3 cas parmi les résidents en 4 jours. GEA : au moins 5 cas parmi les résidents en 4 jours. Signalement à l'ARS sur signalement.social-sante.gouv.fr : volet 1 au signalement, volet 2 à la clôture de l'épisode.

Sources : DGS/DGCS, doctrine IRA en établissements médico-sociaux, janvier 2025 · ARS Auvergne-Rhône-Alpes, procédure IRA en ESMS, avril 2026 · ARS Auvergne-Rhône-Alpes, procédure GEA en ESMS, septembre 2025 · ARS Nouvelle-Aquitaine, signaler des cas groupés IRA/GEA/gale, mars 2025 · signalement.social-sante.gouv.fr

IRA — GRIPPE, COVID-19, VRS…

Dès le premier cas

- **Masque** pour le résident symptomatique ; **hygiène des mains** renforcée ; **aération** des pièces.
- **Confirmation biologique** recommandée, au moins pour les premiers cas (TROD/TDR, PCR multiplex si besoin).

Cas groupés

- Grippe confirmée : **oseltamivir** curatif des personnes à risque et **prophylaxie des contacts** à risque, à discuter par le médecin.
- Signaler dès le seuil atteint (3 cas en 4 jours).

Clôture

- **14 jours sans nouveau cas** (procédure ARS ARA ; suivre la consigne de votre ARS) → volet 2 du signalement.

Sources : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, procédure IRA en ESMS, avril 2026 · DGS/DGCS, doctrine IRA en établissements médico-sociaux, janvier 2025

GEA — GASTRO-ENTÉRITES

Dès le premier cas

- Personnel : **friction hydro-alcoolique**, précédée d'un lavage au savon si mains souillées ou mouillées. Résidents : lavage au savon et à l'eau. Précautions **contact**.
- **Désinfection** de l'environnement et du matériel.

Cas groupés

- **3 à 5 prélèvements de selles** pour recherche virale, selon la procédure ARS.
- Signaler dès le seuil atteint (5 cas en 4 jours).
- Prévenir l'ARS **sans délai** si ≥ 5 nouveaux cas le même jour, pas de baisse 1 semaine après les mesures, ou ≥ 3 décès en moins de 8 jours.

Clôture

- À la fin de l'épisode → volet 2 du signalement.

Sources : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, procédure GEA en ESMS, septembre 2025

ORGANISER LE SUIVI

- Tenir la **liste des cas** (résidents et professionnels) : date de début, symptômes, tests, évolution.
- Tracer la **courbe épidémique** au jour le jour.
- **Informer** les professionnels et les familles.
- Désigner un **référent de l'épisode** (IDEC ou médecin coordonnateur) — proposition DOTR.

Sources : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, procédure GEA en ESMS, septembre 2025 · proposition DOTR

LE MÉDECIN DOTR EN TÉLÉCONSULTATION

- Évaluer les résidents symptomatiques : **signes de gravité**, hydratation, critères de transfert (protocole DOTR « Critères SAMU »).
- Prescrire les tests et, si indiqué, le traitement antiviral.
- Revoir les traitements à risque en cas de déshydratation (diurétiques, IEC/ARA2, metformine, lithium…).

Proposition DOTR.

Sources : proposition DOTR

PRÉVENIR

Vaccination des résidents et des professionnels selon le **calendrier vaccinal en vigueur** (grippe, COVID-19, VRS pour les personnes éligibles) — rubrique Vaccination de l'Espace VMS. Précautions standard toute l'année : fiche socle « Hygiène des mains ».

Sources : Calendrier des vaccinations en vigueur

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical. Seuils : Santé publique France et ARS (doctrine nationale IRA de janvier 2025). Port du masque : instruction DGS/DGCS 2025/139 du 12/11/2025 (non opposable, déclenchement régional, phase pilote 2025-2026).